

Conduire une anamnèse

mardi 1 octobre 2019 14:10

Accueil

Avant de commencer l'anamnèse à proprement parler, il est important de terminer les tâches précédemment commencées. Le dossier du patient doit être à disposition et une relecture au moins de la situation du patient et de son suivi actuel.

Les présentations sont d'autant plus importantes dans un contexte hospitalier où les patients peuvent être amenés à voir plusieurs praticiens différents, avec des fonctions différentes.

Suite aux présentations, il faut énoncer le cadre de l'entretien:

- Cadre temporel: un temps délimité d'avance permet au patient de se faire une idée sur son temps de parole et ainsi adapter son comportement. Ceci évite également des syndrome de la "porte de sortie" ou encore un sentiment de frustration.

"Je passe juste pour me présenter, nous aurons plus de temps pour discuter durant la visite."

"Nous avons 45min à disposition pour discuter et pour que je vous examine"

- Structure: si les objectifs de la consultation sont déjà connus il est utile de les énoncer d'emblée, sans aborder les sujets avec précision.

"C'est la première fois que l'on se voit, je vous propose de faire un peu le point de votre situation"

"La dernière fois nous avions entrepris un traitement médicamenteux, je voulais vous revoir pour faire le point"

Dans un contexte hospitalier, il est possible que la personne ait déjà eu à faire avec un autre médecin. Y faire référence:

"Vous avez déjà expliqué votre état à mon assistant qui me l'a transmis. Je voudrais vous poser d'autres questions"

Anamnèse actuelle

Commencer par une question ouverte, sans présupposer pour permettre au patient de s'exprimer le plus possible.

"Pourriez-vous me dire ce qui vous a motivé à me consulter?"

"De quoi souhaitez-vous que nous parlions aujourd'hui?"

"La dernière fois nous avons abordé le sujet X. Est-ce que vous voudriez parler de quelque chose en particulier ou pouvons-nous revenir un peu plus en détail là-dessus?"

Suite à la plainte du patient, il est utile de reformuler brièvement ce qu'il vient de dire puis de proposer une structure plus précise de l'entretien. Ceci est d'autant plus important si le patient a plusieurs plaintes plus ou moins graves.

⚠ le coté psychosocial peut déjà être mis en jeu à ce moment-là ⚠

"Alors si j'ai bien compris [reformulation]. Je vous propose donc que l'on parle d'abord [plan]."

"J'ai l'impression que vous êtes particulièrement touché par [événement psy], je vous propose que l'on s'occupe d'abord de [problème le plus important] puis qu'on prenne un moment pour discuter de ça."

"Pour moi le plus inquiétant est votre problème pulmonaire. On va s'y attarder d'abord puis nous reviendront sur vos érythèmes si vous êtes d'accord"

Plus on avance dans l'entretien, plus les questions doivent devenir ciblées. On part d'une question ouverte puis on enchaîne sur des questions ciblées. Elles ont l'avantage de laisser encore un peu de liberté au patient mais dans un domaine. Les questions fermées sont réservées à la précision de certaines informations manquantes dans le récit du patient.

Les questions peuvent permettre d'exclure ou de confirmer une maladie:

- L'élément X est toujours présent dans la maladie Y → exclure une maladie (sensibilité)
- L'élément X est exclusivement présent lors de la maladie Y → confirmer une maladie (spécificité)

Traiter le motif de consultation

Si le motif est un bilan de santé, il n'y a pas de caractérisation spécifique à faire et l'analyse par système peut directement être entreprise.

Si le motif est une douleur ou un symptôme, il est important de les caractériser au travers 7 points:

0) Introduire le fait que l'on va caractériser sa douleur / son symptôme pour mieux cerner ce dont il souffre.

1) Localisation de la douleur et irradiations

"Pouvez-vous me montrer où vous avez mal?"

"Est-ce que cette douleur précisément ici ou est-ce qu'elle diffuse dans toute votre cage thoracique?"

Il est important de regarder comment le patient montre sa douleur (bout du doigt ou main complète). S'il indique qu'il a mal partout, il faut insister en demandant de montrer du doigt où est ce que ça lui fait le plus mal.

Skills

- Relecture du dossier

- Présentations

- Annoncer le cadre temporel et structurel de l'entretien

- Réfléchir aux objectifs

- Faire référence à l'intervenant précédant

- Questions ouvertes, sans interruption

- Reformuler
- Hiérarchiser les plaintes et restructurer l'entretien au besoin

- Questions:
Ouvertes → ciblées → fermées

- 7 questions pour qualifier le symptôme

2) Qualité

"Pourriez-vous me décrire comment vous ressentez cette douleur?"

Les informations données peuvent aiguiller sur le type de pathologie (exemple):

Constriction / serrement / pression / étou	Infarctus du myocarde
Sensation de déchirement / arrachement	Lésions d'organes comme une déchirure de l'œsophage
Aigüe / coup de poignard	Infarctus / dissection aortique
Choc électrique / aiguilles / sourde	Troubles anxieux
Brûlures	Reflux gastriques

Soit le patient est imaginatif, soit il est nécessaire de forcer en donnant des exemples.

3) Intensité

"Si je vous demandais de noter votre douleur sur une échelle de 0 à 10 elle serait à combien? ... Est-elle constante?"

Préciser le fonctionnement de l'échelle si aucune réglette n'est à disposition.

0 → absence de douleur

10 → la douleur la plus horrible que vous pouvez imaginer

Cette évaluation est très subjective et ne reflète pas forcément le vrai ressenti du patient. Elle est dépendante de nombreux facteurs comme l'éducation ou l'origine culturelle du patient. Elle peut également révéler un contexte psychologique (exagération des symptômes).

Cette évaluation reste cependant intéressante pour qualifier l'évolution de cette douleur.

La douleur peut également évoluer d'intensité durant une crise ou le moment de la journée.

4) Chronologie

"Depuis quand avez-vous ces crises? En général combien de temps durent-elles?"

Quatre points sont à évaluer: Début, Fin, Durée des crises, Fréquence des crises

5) Conditions de survenue

"Avez-vous réussi à identifier un élément particulier qui déclenche ces douleurs?"

Quelques exemples typiques:

- o Position du corps (couché vs. assis)
- o Toux / respiration
- o Froid / chaud
- o Stress / fatigue
- o Effort physique
- o Déglutition / composition du repas

Reflux gastrique: lorsque la personne se couche ou se penche pour lacer ses chaussures la douleur apparaît.

Pneumonie: lorsque la personne tousse elle a mal → fracture de côtes suite à un effort de toux.

6) Facteurs de modification

"Avez-vous trouvé quelque chose d'efficace pour faire diminuer la douleur?"

→ au besoin, évoquer la position du corps, le froid / chaud, les médicaments, remèdes de grand-mère

7) Manifestations associées

"Avez-vous remarqué d'autres sensations en même temps que les douleurs?"

Sont importants à traiter:

- Dyspnée
- Nausée / vomissements
- Toux
- Sueurs
- Syncopes / paralysies
- Dysphagie

"Est-ce qu'ils vous est arrivé de transpirer la nuit au point de devoir changer de pyjama ou de draps?"

"Avec vous eu l'impression de tomber dans les pommes?"

Ces signes seuls ou cumulés peuvent être signes de complications. Une bradycardie peut par exemple être suspectée par l'accumulation d'une douleur thoracique, d'une sudation, et de syncopes.

Anamnèse par système

Le but est de déceler un éventuel dysfonctionnement d'un système pour aiguiller les hypothèses de diagnostic. Ceci se fait en posant des questions clés en parcourant les différents systèmes. Si l'ensemble des questions sont répondues négativement, on peut à priori considérer que le système est OK.
Le piège est que certaines questions peuvent correspondre à plusieurs systèmes. Typiquement, le cardiovasculaire et le respiratoire sont souvent liés.

"Maintenant que j'ai bien compris ce que vous ressentez, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre état de santé pour pouvoir mieux me situer."

Pour commencer, une vue globale est nécessaire puis il faut parcourir un ou plusieurs des 8 systèmes selon les plaintes du patient et les suspicions que l'on pourrait avoir:

Cardiovasculaire, thoracique, digestif, uro-génital, dermatologique, neurologique, ostéoarticulaire, psychiatrique

Général

Cette partie permet de connaître un peu mieux l'état général du patient sur la base de ses propres observations, mais également son ressenti par rapport à ce qu'il vit.

"De manière générale est-ce que vous vous trouvez en bonne santé?"

Les points à aborder sont:

- Poids (prise / perte, fluctuation) → pour le dossier ou la visite médicale, il est plus parlant de calculer le BMI. La prise de poids subite peut être due à un œdème, possiblement signe d'une insuffisance cardiaque.
- Température (si pas demandée durant la qualification du symptôme)
- Adénopathies

"Avez-vous des ganglions / comme des boules dures au niveau de... ?"

- Sudation importantes, principalement nocturne
- Allergies aux médicaments ou non

Cardiovasculaire (partie cardiaque)

Les points à aborder sont:

- Douleurs thoraciques
- Palpitations (vitesse, irrégularité). Il faut éviter au maximum d'utiliser le mot palpitation car il n'a pas la même signification médicale que courante et peut porter à confusion.

"Avez-vous remarqué que votre cœur bat plus fort / vite / irrégulièrement?"

- Orthopnée est causée par la remise en circulation de l'eau causée par des œdèmes. Cet apport d'eau dans les poumons cause des difficultés respiratoires lorsque la personne se couche. En général, les gens se lèvent et vont mieux.

"Avez-vous de la peine à respirer lorsque vous vous couchez?"

- Dyspnées paroxystiques nocturnes est une sensation d'étouffement au milieu de la nuit, causée par un œdème pulmonaire aigu.
- Pollakiurie nocturne est le drainage des œdèmes créés en journée la nuit, grâce à la position couchée.

"Vous arrive-t-il de devoir vous lever la nuit pour aller aux toilettes? À quelle fréquence? Est-ce que c'est quelque chose qui a augmenté ces derniers temps?"

Cette situation peut être causée par une insuffisance cardiaque. Si le phénomène est très prononcé, il faut envisager une urgence.

- Œdèmes des membres inférieurs
- Dyspnées

Cardiovasculaire (partie vasculaire)

Les points à aborder sont:

- Douleur des membres inférieurs
- Œdèmes des membres inférieurs
- Varices
- Ulcères des membres inférieurs et autres lésions cutanées
- Doigts blancs / bleus (phénomène de Raynaud)

Tous ces signes peuvent être causés par des souffrances des artères ou des veines. Une des conséquences des douleurs voire des ulcères sont les ischémies à cause d'une vascularisation compromise.

Les œdèmes en fin de journée ou après une longue période à rester debout sont normaux, il n'y a pas lieu de pousser les investigations dans ces conditions.

- Indiquer à nouveau au patient la suite de l'entretien, reformuler si nécessaire

- Expliciter les transitions / introduire

- Anamnèse par système

- Prise en compte de l'aspect psychosocial de la maladie

- Contextualiser un symptôme pour aider à la mémorisation

- Status cardiovasculaire

Pulmonaire

Les points à aborder sont:

- Douleur thoracique elles ne sont pas spécifique au système pulmonaire mais également cardiovasculaire voire des troubles anxieux.
- Dyspnée, à classer selon les stades NYHA (New York Heart Association)

Stade I	Dyspnée suite à un gros effort physique	Sprint 100m, Marathon
Stade II	Dyspnée suite à des efforts physiques importants	Courir, monter des escaliers (> 2 étages)
Stade III	Dyspnée suite à des efforts modérés	Parler, ménage, monter des escaliers (< 2 étages)
Stade IV	Dyspnée au repos	Brosser les dents, manger, se mettre debout, marcher

"Combien pouvez-vous monter d'étages avant de vous sentir essoufflé?"

"Quels activités du quotidiens deviennent pénibles au point que vous deviez prendre une pause pour respirer après?"

"Est-ce que vous avez remarqué une baisse du nombre d'étages ou du nombre d'activités que vous pouvez faire avant de vous sentir essoufflé?"

Ces signes peuvent faire penser à une thrombose. Comme les symptômes s'installent progressivement, les patients ne se rendent pas forcément compte de ce qu'il leur arrive. C'est pour cela qu'il faut éviter de demander directement s'ils ont des difficultés à respirer, souvent la réponse sera négative.

- Toux sèche ou purulente
- Expectorations (couleur, volume, sang, difficulté à expectorer)
Chez les fumeurs, elles peuvent être habituelles. Il faut donc faire attention au contexte. Les changements de qualité sont importants, notamment la couleur (transparent → jaune = signe d'infection) ou la présence de sang. Pour cette dernière, il faut définir:
 - Petit filet coloré pouvant résulter d'une microlésion suite à un effort de toux
 - Coloration rouge nettement plus graves

- Asthme et ses éléments déclenchants
- Ronflements

Lors d'apnées du sommeil, la reprise de la respiration est très bruyante. Le/la conjoint peut être témoin de ces choses-là.

"Dernièrement est-ce que votre partenaire se plaint que vous ronflez plus ou plus bruyamment que d'habitude?"

Digestive

L'idée générale est de faire un bilan des entrées et sorties.

Entrées	Sorties
Nourriture Boissons	Urines Selles Vomissements

En plus de regarder la quantité, il faut évaluer la qualité. Par exemple pour l'alimentation, la nourriture peut ne pas passer mais les boissons oui.

Les points à aborder sont:

- Dysphagie
- Nausées / vomissements
- Pyrosis (brûlures remontant de l'estomac vers la bouche → signe presque spécifique des reflux gastro-œsophagiens)
- Réplétion gastrique (moment à partir duquel la satiété s'installe. Après 2 morces, avant le repas, ...)
- Douleurs abdominales
- Selles
 - ✧ Fréquence par jour, puis par semaine
 - ✧ Aspect (couleur / odeur)
 - ✧ Présence de sang (préciser la quantité)

La fréquence change énormément des personnes, pouvant aller de 2-3 fois par jour, à 2-3 fois par semaine. Le plus important est de caractériser les changements de fréquences.

- Ictère (le meilleur moyen est de regarder directement le patient. Les conditions lumineuses doivent être bonnes)
"Ces derniers temps avez-vous remarqué un changement de couleur de votre peau?"

Génito-urinaire

Les points à aborder sont:

- Urines
 - ✧ Fréquence
 - ✧ Quantité
 - ✧ Aspect (couleur / odeur)
 - ✧ Présence de sang

La couleur peut être influencée par l'alimentation (fruits rouges, betterave) mais également suite à une activité physique intense. Les souffrances musculaires peuvent créer des lésions et l'excrétion de myoglobine dans les urines.

- Dysurie (accompagnée de douleur ou de brûlures)
- Douleurs de la loge rénale
- Fonctions sexuelles (libido, douleur, troubles divers)
- Menstruations (début, fin, aménorrhées, dysorrhées)
- Pertes vaginales

• Status pulmonaire

• Status digestif

• Status urologique / gynécologique

Neurologique

Les points à aborder sont:

- Acuité visuelle / auditive
- Vertiges
- Céphalées

Elles ne sont pas forcément pathologiques mais par exemple dues à une situation stressante. C'est à nouveau la fréquence et les changements récents qui sont importants.

- Epilepsie et leurs éléments déclenchants
- Troubles de la sensibilité (mécanique, vibratoire, thermique)
Pour tester la sensibilité il est possible d'utiliser des cotons tiges, des épingles de sûreté ou d'autres objets pouvant faire l'affaire. Pour la sensibilité thermique, il suffit de remplir des tubes à essai d'eau plus ou moins chaude.
- Troubles moteurs
- Troubles de l'équilibre
- Douleurs de type décharges électriques ou brûlure, qui sont les principaux ressentis lors de troubles neurologiques
Une douleur qui part du dos et se dirige antérieurement comme un courant électrique peut être une piste de sarcoïdose, compression d'un nerf, fracture vertébrale, névrite sur maladie de Lyme.
- Troubles cognitifs en utilisant le Mini Mental State (MMS)
C'est un test standardisé évaluant l'état d'un patient lors de divers exercices:
Orientation (temps et lieux), Apprentissage et mémorisation de mots, Calcul mental simple, Dessin, Ecriture, etc.

Ostéoarticulaire

Les points à aborder sont:

- Douleurs articulaires
- Œdèmes et / ou rougeur articulaire
- Limitation fonctionnelle d'une membre
- Perte de taille supérieure à 4cm

Un changement rapide de la taille peut être dû à une fracture vertébrale. Elles peuvent conduire à un diagnostic d'ostéoporose ou de myélome. Il faut cependant une taille perdue supérieure à 4cm dans un laps de temps d'environ une année. La perte de taille est cependant normale avec l'âge à cause de la perte de teneur en eau des disques intervertébraux. En général, cette diminution est accompagnée d'une cyphose à cause du manque de tonus musculaire du dos.

- Douleurs osseuses

Dermatologique

Les points à aborder sont:

- Eruption cutanée
- Dyscoloration cutanée
- Boutons et tous ses dérivés
- Lésions cutanées
- Pilosité

Lors de maladie comme celle de Cushing, il est possible que l'augmentation de corticostéroïdes provoque l'augmentation de la pilosité.

Psychiatrique

Les points à aborder sont:

- Anxiété / dépression
"Avez-vous déjà vécu des épisodes d'anxiété / de déprime?"

Il est intéressant de poser quelques questions sur le contexte psychosocial car il permet de mettre en évidence plusieurs éléments pouvant causer ces troubles.

- Comportements à risque notamment l'abus de substances
La consommation de drogues ou d'alcool doit être amenée avec subtilité, par exemple en faisant le lien avec les repas.
- Troubles du caractère
- Éléments de la lignée psychotique
 - ✧ Fuite des idées
 - ✧ Hallucinations
 - ✧ Hypomanie (trouble de l'humeur caractérisé par de l'irritabilité, une excitation persistante et omniprésente)

Certaines visions peuvent être causées par des maladies ophtalmologiques comme le syndrome de Charles Bonnet (visions complexes associées à une cécité partielle comme la cataracte, le glaucome, ...).

En général les troubles du comportements sont visibles et ne requièrent pas de questions particulière.

• Status neurologique

• Status rhumatologique

• Status dermatologique

• Status psychiatrique

• Modèle biopsychosocial

Hypothétiser

Une fois que les informations ont été collectées, il est important de faire déjà une ou plusieurs hypothèses pour pouvoir cibler un peu plus la suite de l'entretien. Il n'est pas exclu que le patient montre des signes ou explicite une certaine anxiété face à une éventuelle maladie. Il peut être réconfortant ou cadrant pour lui de formuler les hypothèses à voix haute mais sans se prononcer sur un diagnostic. Ceci est d'autant plus important s'il n'y a pas d'urgence.

Les hypothèses formulées doivent être classées de la plus dangereuse à la moins dangereuse. Ensuite, chacune est prise dans l'ordre et évaluée au vu des informations récoltées durant cette première partie de l'entretien, mais également une fois que toutes les informations y compris celles de l'examen clinique et paraclinique sont là.

Anamnèse personnelle

Elle vise à contextualiser le patient dans son environnement et ses habitudes. De l'anamnèse personnelle et des antécédents familiaux, il est possible de dresser les facteurs de risques auxquels est confronté le patient.

- Etat général ressenti par le patient
Le contexte émotionnel du patient peut faire ressortir une angoisse ou d'autres émotions.
- Les vaccinations effectuées
- Risques liés à l'environnement
Le lieu de vie peut être propice à différents risques notamment les allergies pour les personnes habitant en campagne ou en présence d'animaux.

- Exercice et loisirs
- Habitudes alimentaires
- Alcool, tabac, substances toxiques
Ces sujets sont délicats à traiter. Pour l'alcool, il est possible d'introduire le sujet avec les habitudes alimentaires. Sinon, il est possible d'utiliser une question qui a démontré une relativement bonne validité statistique:
"L'année passée, combien de fois avez-vous pris plus que X verres dans une journée?"

Références: RMS n°264, sept. 2010

Si la réponse est égale ou supérieure à 1, la consommation est considérée comme problématique.

X diffère selon les hommes et les femmes:

Hommes	X = 8
Femmes	X = 6

Ces chiffres sont calculés à partir des recommandations de l'OMS.

	Doses par semaine	Doses par occasion
Hommes	21	4
Femmes	14	3

Les questions impliquant une tierce personnes sont également mieux reçues par le patient car elles sont moins accusatrices.

"Est-ce qu'il vous arrive à vous ou un membre de votre entourage proche de consommer autre chose que du tabac et / ou de l'alcool?"

- Sexualité

Antécédents personnels

Ici sont recherchés les antécédents médico-chirurgicaux comme:

- Maladies et leurs traitements
- Accidents et blessures
Il est important, lors de fractures, d'essayer de quantifier l'énergie. Par exemple, une personne qui chute d'une hauteur égale à la sienne ne devrait pas avoir de fracture. Si c'est le cas, il peut y avoir une indication pour une fragilisation des os notamment ostéoporotique.
- Opérations
- Hospitalisations

Pour chaque item, il faut préciser:

- Chronologie
- Circonstances
- Médecins
- Hôpitaux

Certaines personnes peuvent oublier certains épisodes peu traumatisants. Il est donc utile d'insister plusieurs fois avec des questions légèrement modifiées pour être sûr de gommer ces omissions.

"Avez-vous déjà été hospitalisés?"

"Avez-vous déjà consulté un médecin pour une raison particulière?"

"Avez-vous été opéré?"

"Y aurait-il eu par hasard une autre hospitalisation avant ou après cet événement?"

"Par hasard y avait-il une autre maladie pour laquelle vous étiez suivi?"

La révélation de traitements aux possibles effets secondaires sur le long terme peut orienter le diagnostic. Par exemple, un traitement à la cortisone pour lutter contre une inflammation peut favoriser de nombreuses maladies comme un diabète ou une ostéoporose.

Antécédents familiaux

Evidemment, ce ne sont que les parents / enfants directs qui sont concernés biologiquement. Cependant, la connaissance de proches ayant soufferts d'une pathologie peut avoir des répercussions sur le moral de la personne, voire même lui insuffler la peur d'avoir la même pathologie car il peut y avoir des points de ressemblance. Dans ces conditions, il est important de préciser la composante familiale sans pour autant négliger ce que la personne ressent.

- Pathologies retrouvées dans la famille
- Pathologies et causes de décès des parents
Il est impératif de demander l'âge à laquelle ces personnes ont fait certaines maladies ou sont décédées. Par exemple un infarctus du myocarde fait à 65 ans est moins inquiétant qu'à 40.
"Est-ce que vous savez de quoi est décédé votre père? À quel âge?"
- Pathologies des frères et sœurs, avec l'âge à nouveau
- Pathologies des enfants

Certaines maladies comme le cancer du sein ou du colon peuvent avoir des composantes familiales.

Anamnèse psychosociale

Le contexte psychosocial dans lequel le patient évolue peut influencer très clairement l'évolution ou l'étiologie d'une pathologie. On pensera tout spécialement aux crises d'angoisse qui peuvent dégénérer en douleurs thoraciques ou musculosquelettiques.

- Situation sociale
État civil, vie de famille, et comment la personne vit ceci.
- La vie au quotidien (description d'une journée type)
- Activité professionnelle
Certaines professions sont plus à risques que d'autres du point de vue de l'exposition à certaines toxiques ou risques. Même si une personne est retraité, il est important de savoir dans quel domaine elle travaillait avant.
- Le parcours de vie
- Les croyances religieuses

Cette partie de l'entretien sert plus à créer une relation de confiance avec le patient qu'à réellement collecter des informations cruciales. Il est donc utile d'introduire cette partie de l'anamnèse d'un point de vue plus "amical":

"J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vous, pour mieux apprendre à vous connaître"

Chez les personnes âgées, ces informations peuvent permettre d'organiser le suivi d'un traitement par un proche ou un retour à la maison suite à une hospitalisation.

Traitements

Chaque médication que le patient prend suite à ses antécédents médicaux peuvent avoir des effets secondaires. Il est important de vite contrôler qu'il n'y ait pas de lien entre un possible effet secondaire (même rare) d'un médicament avec les informations récoltées lors de l'anamnèse. Même si un traitement semble être bien toléré, il peut présenter des effets secondaires à long terme par exemple.

Il faut vérifier:

- Traitements réguliers
- Traitements occasionnels
- Les substances annexes (vitamines, plantes, substituts)

"Vous arrive-t-il d'acheter des compléments alimentaires ou autre thérapies sur Internet?"

Certains compléments à base de plantes notamment peuvent provoquer des intoxications, surtout si les patients font leur propres posologies.

Expliquer et planifier

Pour le dossier / visite médicale

La structure décrite ci-dessus est difficile à respecter car l'anamnèse se fait sous la forme d'une discussion entre le médecin et le patient. Il est donc important de tout remettre dans un bon canevas pour permettre une lecture plus simple des informations. Pour la présentation de cas ou pour le dossier médical, il est important:

- De sélectionner les informations pertinentes. L'hospitalisation à 5 ans pour une fracture de la dernière phalange n'est pas important si la plainte du patient ne concerne pas directement les conséquences de cet incident.
- Présenter brièvement le patient au début d'une transmission:
Monsieur / Madame [nom ou première lettre si le secret doit être gardé], un/e [sexe] de [âge], a un BMI de [valeur] et consulte pour [plainte].
- Présenter le reste de manière structurée
- Mentionner tous les signes évalués qui ne sont pas présents, pour éviter une confusion entre l'absence du symptôme et l'oubli de l'examineur (pas de toux, pas de dyspnée mesurée, ...).

- Rassurer / faire preuve d'empathie

- Construction d'une relation de confiance avec le patient

- Synthèse et restitution de l'information
- Structure souple mais logique

Pour le patient

La fin de l'anamnèse doit impérativement se poursuivre avec un examen clinique. Les patients attendent que le médecin les examine et les touchent. Cette pratique relève plus du rituel mais elle contribue énormément à la construction de la relation médecin - patient (au-delà de pouvoir apporter des indications supplémentaires à l'anamnèse).

Même si l'examen clinique n'est pas nécessaire, il faut en faire un.

Un patient satisfait, actif et en confiance est un patient qui adhère mieux au traitement que le médecin lui propose.

Une fois tout ceci terminé, il faut communiquer le diagnostic au patient ainsi que les suites de la prise en charge. A ce moment-là, il faut prendre en considération que le patient ne va pas retenir toutes les informations, encore moins si le diagnostic posé est grave. Il faut veiller à :

- Donner le minimum d'information en même temps, juste celles qui sont nécessaires à tenir jusqu'à la prochaine consultation
- Indiquer la suite des procédures (opération, médication, consultation chez un spécialiste)
- Si la situation n'est pas urgente, présenter les alternatives thérapeutiques si elles existent:
Investigations, médication, changement de mode de vie (alimentation, sport, alcool, fumée, toxines, ...)

Quelques astuces sont souvent sous-utilisées et permettent d'améliorer la compréhension par le patient :

- Utiliser des schémas
- Rédiger une petite note écrite pour le patient
- Demander au patient de reformuler dans ses mots ce qu'il a compris pour s'en assurer

Clôture de la consultation

Pour éviter au maximum un syndrome de la porte de sortie, il faut garder un certain temps à disposition pour un éventuel non-dit lors de la consultation. Il est important de rouvrir la discussion soit avant soit après avoir présenté le plan de traitement.

"Est-ce qu'il y aurait autre chose dont vous voudriez discuter avant que vous partiez?"

Une dernière reformulation du plan de traitement et de la suite des événements peut aider à clore la consultation.

Un syndrome du pas de la porte est souvent signe que le patient n'a pas pu suffisamment s'ouvrir durant la consultation, très souvent par manque de temps de parole. Selon les patients, il reste nécessaire de structurer l'entretien à de multiples reprises en hiérarchisant les problèmes soulevés.

"J'ai bien compris que le décès de votre chat vous touche. Je vous propose de terminer de discuter de votre douleur thoracique puis nous pourrions prendre le temps pour en parler."

Gestion des émotions

L'empathie est la capacité de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un pour pouvoir comprendre ses ressentis. C'est une composante à la fois émotionnelle et cognitive. Elle ne veut pas dire qu'il faut souffrir en même temps que le patient (= sympathie), chose qui n'est pas constructive.

Face à l'émotion d'un patient, quelques situations sont à proscrire :

- ⊗ Se focaliser sur les aspects médicaux uniquement
- ⊗ Se mettre dans une attitude de non disponibilité
- ⊗ Consolations précoces: *"Tout va s'arranger, ne vous en faites pas."*

Il est préférable de légitimer les craintes du patient tout en essayant de le rassurer dans la limite du réel, sans faire de fausses promesses.

"Je comprends tout à fait que cette nouvelle vous fasse peur, c'est tout à fait normal."

Il est impératif de laisser au patient le temps de digérer la nouvelle. Comme ils sont en général pudiques, ça ne prend jamais des lustres.

"Prenez seulement le temps de vous ressaisir, nous en discuterons calmement après."

La discussion est impérative, il ne faut surtout pas éviter ou quitter le sujet sans transition. Il faut expliciter les craintes du patient et identifier / nommer ses émotions. Une fois en accord avec le patient, il faut offrir son aide et son soutien.

Une fois que le moment émotionnel est terminé, le patient sera beaucoup plus réceptif à la suite de la consultation.

- Renforcement de la relation médecin - patient

- Type et qualité des informations transmises

- Méthodes de transmission de l'information

- Rester ouvert

- Snd. du pas de porte

- Empathie vs. Sympathie

- Situations à éviter

- Gestion de l'émotionnel du patient, utilisation de l'empathie

L'anamnèse : exercice pratique

Dr Olivier Lamy
Service de Médecine Interne



Strucuture de l'anamnèse

- Anamnèse actuelle
- Anamnèse par système
- Antécédents personnels
- Anamnèse personnelle
- Antécédents familiaux
- Anamnèse psychosociale
- Les traitements

Anamnèse actuelle

- Motif de consultation :
 - 1) plainte, souffrance
(patient atteint dans sa santé)
 - 2) bilan de santé
(patient peut être en bonne santé)

Les caractéristiques d'un symptôme

- 1. Localisation et irradiation
- 2. Qualité (serrement, colique, brûlure, décharge électrique)
- 3. Intensité (échelle de 0 à 10)
- 4. Chronologie (début, fin, durée, fréquence)
- 5. Condition de survenue
- 6. Facteurs le modifiant (aggravant ou soulageant)
- 7. Manifestations associées

Anamnèse par système

- Cardiovasculaire
- Pulmonaire
- Digestif
- Génito-urinaire
- Neurologique
- Ostéo-articulaire et musculaire
- Dermatologique

A. Système : pulmonaire

- 1. Douleurs thoraciques
- 2. Dyspnée (stades 1 à 4)
- 3. Toux
- 4. Expectorations (volume, sang)
- 5. Asthme (facteurs déclenchants)
- 6. Ronflements

A. Système : digestif

- 1. **Dysphagie (liquides, solides)**
- 2. **Nausées, vomissements**
- 3. **Pyrosis**
- 4. **Réplétion gastrique**
- 5. **Douleurs abdominales**
- 6. **Selles : fréquence, qualité, incontinence**
- 7. **Ictère**

Antécédents personnels

(antécédants médico-chirurgicaux)

- Les maladies et leurs traitements
- Les accidents et les blessures
- Les opérations
- Les hospitalisations

Anamnèse personnelle

- Etat général ressenti par le patient
- Les vaccinations
- Les risques liés à l'environnement
- Exercice et loisirs
- Habitudes alimentaires
- Alcool, tabac, substances toxiques

Antécédents familiaux

- Pathologies retrouvées dans la famille
- Pathologies (et causes de décès) des parents et grands-parents
- Pathologies chez les frères et sœurs
- Pathologies chez les enfants

Anamnèse psychosociale

- La situation à domicile
- La vie au quotidien
- Les expériences importantes
- Les croyances religieuses
- Les opinions du patient

Les traitements

- Le traitement régulier
- Les traitements occasionnels
- Les « substances annexes »
 - vitamines
 - plantes, etc...